Prescrições na Emergência

Guia Prático

O ideal é que se pense no todo, mas atue nos detalhes...

Guia prático para seu plantão na emergência

"Este produto é destinado exclusivamente a profissionais da área de saúde. O exercício de atividades regidas pelos conselhos profissionais sem a devida habilitação constitui uma atividade ilegal."

SUMÁRIO

Aminas Vasoativas 7

Intubação 8

Arritmias 10

Síndrome Coronariana Aguda 14

TVP e TEP 16

Edema agudo de pulmão 17

Asma 18

DPOC 19

Hemorragia Digestiva 21

Cetoacidose 22

SUMÁRIO

Antimicrobianos 23

Analgésicos 24

Vitaminas 26

Hemocomponentes 28

Encefalopatia hepática 31

Albumina 32

Cólica nefrética 33

Enxaqueca 34

Crise Convulsiva 36

Hipertensão intracraniana 37

SUMÁRIO

Distúrbios do K 38

Distúrbios do Na 40

Distúrbios do Ca 42

Distúrbios do Mg 44

Constipação 45

Diarreia 46

Otites 47

Sinusite 48

Conjuntivite 49

Herpes Zoster e Simplex 50

SUMÁRIO

Sífilis 51

Corrimento Vaginal 52

Uretrites 54

Lombalgia 55

Anafilaxia e alergias 56

Controle glicêmico na UTI 58

Paracetamol - Intoxicação 59

"Chumbinho" - Intoxicação 60

Cocaína - Intoxicação 61

Vertigem 62

AMINAS VASOATIVAS

1 . Noradrenalina (4 mg / 4 ml-ampola) - Diluição padrão

Diluir 5 ampolas (20 ml) em 180 ml SF 0,9% ou SG 5%

2. Dobutamina (250 mg / 20 ml - ampola) - Diluição padrão

Diluir 1 ampola (20ml) em 230 ml SG 5%

Resultando em uma concentração de de 1.000 mcg/ml

mcg/kg/min: ml/h x 1000 / 60 / peso

3. Nitroglicerina (Tridil) (50mg/5mL - ampola)

Diluir 1 ampola em 245ml de SG5%

4. Nitroprussiato de sódio (Nipride) (400 mcg / 2ml - ampola)

Diluir 1 ampola em 248 ml de SG5%

5. Dopamina (50 mcg / 10 ml - ampola) Diluição padrão

Diluir 5 ampolas + SF 0,9% ou SGI 5% 200ml

Resultado em uma concentração de 1.000 ug/ml

6. Vasopressina (20 U / ampola) - Diluição padrão

Diluir 1mL em 200 ml de SGI 5 % ou SF 0,9% (0,1 U/ml)

Resultando em uma concentração de 0,1 U/ml

INTUBAÇÃO

Dose para adulto (70 Kg)

1. Fentanil (10ml - ampola - 5Oug/ml)

Dose: 3ug/Kg

Paciente 70kg -> Fazer 4 mL da ampola IV lentamente

2. Etomidato (10ml- ampola - 2mg/ml)

Dose: 0,3mg/Kg

Paciente 70Kg -> Fazer 10 ml da ampola IV lentamente

3. Succinilcolina (10mL - frasco/ampola - 10mg/ml)

Dose: 1,5mg/Kg

Paciente 70Kg -> Diluir 1 ampola (100mg/10ml) em 10ml de ABD e fazer 10ml IV

ou

4. Rocurônio (5ml- ampola - 10mg/ml)

Dose: 1,5mg/Kg

Paciente 70Kg -> Fazer 7ml da ampola IV lentamente

5. Quetamina (10ml - ampola - 50mg/ml)

Dose: 2,0 mg/Kg

Paciente 70Kg -> Fazer 3,0ml da ampola IV lentamente

INTUBAÇÃO

Sedação pós intubação

1. Fentanil 50mcg/ml - 10ml / ampola

Diluir 40ml (4 ampolas) de Fentanil em 160ml de NaCl 0,9% - Iniciar a 5-8ml/h

+

2. Midazolam 50mg/10ml

Diluir 40ml (4 ampolas) de Midazolam em 160ml de NaCl 0,9% - Iniciar a 5-8ml/h

Opções:

- **Cetamina 50mg/ml - ampola 10ml**

Diluir 2 ampolas em 80ml de SF 0,9% e iniciar EV na BIC a 3-6ml/h

- **Morfina (10mg/ml)**

Diluir 2 ampolas em 98ml de SF 0,9% e iniciar em BIC a 5ml/h

ARRITMIAS

Taquicardia supraventricular

1- Adenosina (6mg/2ml) ---------- 1 ampola - Dose inicial

Fazer 1 ampola em bolus rapidamente seguida de flush de 20ml de SF 0,9%

Se ausência de resposta:

2- Adenosina (6mg/2ml) ---------- 2 ampolas

Fazer 2 ampolas em bolus rapidamente seguida de flush de 20ml de SF 0,9%

Cuidados:

- Fazer metade do dose em: Pacientes transplantados ou com acesso venoso central.
- Evitar em pacientes asmáticos descompensados.

ARRITMIAS

Taquicardia ventricular

1- Amiodarona (150mg/3ml) ---------- Dose de ataque

Diluir 1 ampola em 100ml de SGI 5% e correr em 30min

2- Amiodarona (150mg/3ml) ---------- Dose de impregnação

Diluir 6 ampolas (900mg) em 230ml SGI 5% e correr em BIC a 10ml/h

ARRITMIAS

Controle da FC em FA ou Flutter

1. Metoprolol (5mg/5ml - Amp) ---------- 1 ampola

- Fazer 1 ampola EV em 5 min;
- Pode ser repetida a cada 5min;
- Dose máxima de 15mg.

Opção:

2. Deslanosídeo 0,4mg/2ml ---------- 1 ampola

Fazer 1 ampola EV lentamente

ARRITMIAS

Sedação para cardioversão elétrica

1- Etomidato (2mg/ml - ampola 10ml)

- Pré-medicar com 2ml de fentanil
- Após 2 min, infundir na dose de 20mg (10ml) em bolus
- Não causa broncoespasmo ou depressão cardiovascular

Opções:

2- Propofol (ampolas a 1% - 1ml = 10mg)

- 30-50mg IV em bolus

3- Midazolam (ampolas de 3mL com Smg,/mL)

- 3-5mg (1ml) em bolus; pode-se repetir até sedação adequada.
- Indução rápida, mas efeito prolongado. Parcialmente revertido pelo flumazenil.

SÍNDROME CORONARIANA AGUDA

Uso oral

1- AAS 100mg ---------- 3cp
Tomar 3cp dose de ataque; seguido de 1cp de 24/24h

2- Ticagrelor 90 mg ---------- 2cp
Tomar 2cp dose de ataque; seguido de 1cp (90mg) de 12/12h

ou

2- Clopidogrel 75mg ---------- 4cp
Tomar 4cp dose única; seguido de 1cp (75mg) de 24/24h
Se paciente for para ICP -> bolus de 600mg

3- Atorvastatina 40mg ---------- 1cp
Tomar 1cp

4- Isordil 5mg ---------- 1cp
Dar 1cp sublingual se dor torácica

Uso subcutâneo

5- Enoxaparina 60mg ---------- 1 ampola
Aplicar 1 ampola (1mg/kg) de 12/12h; Se idade maior que 75 anos, reduzir dose para 0,75mg/kg SC de 12/12h; Pacientes com Clearence de creatitina < 30 ml/min, usar metade da dose (1mg/kg/dia)

Uso intravenoso

6-Nitroglicerina (tridil) 50mg/ml ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 230ml de SF 0,9% e correr em BIC em caso de dor torácica persistente ou sinais congestivos. Iniciar dose baixa: por exemplo 5ml/h

SÍNDROME CORONARIANA AGUDA

Trombólise

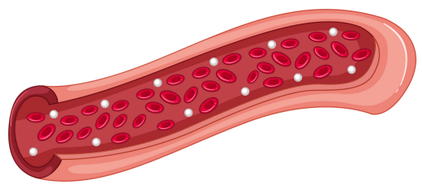
Uso intravenoso

1-Alteplase ---------- Dose máxima: 100mg

- Bolus de 15mg
- 0,75mg/Kg durante 30min (máximo de 50mg)
- 0,50 mg/Kg durante 60min (máximo de 35mg)

<u>Contraindicações absolutas à trombólise</u>

- AVC hemorrágico prévio
- AVC isquêmico nos últimos 3 meses
- Lesão estrutural do SNC (malformação vascular, câncer primário ou metastático)
- Cirurgia do SNC ou medular nos últimos 2 meses
- Suspeita de dissecção de aorta
- Sangramento ativo (exceto menstruação)
- Trauma facial ou TCE grave nos últimos 3 meses Hipertensão arterial grave e não controlada



TVP E TEP

Uso subcutâneo

1.Enoxaparina ---------- SC

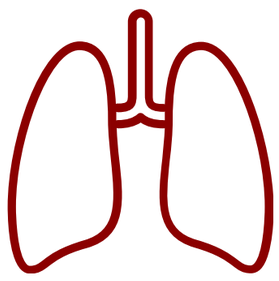
Aplicar 1mg/Kg de 12/12h ou 1,5mg/Kg de 24/24h

Heparinização terapêutica em BIC

1. Heparina não fracionada (5.000 U/ml) ---------- IV

Diluir 5ml (25.000 U) em 250ml de SF 0,9% - 100U/ml

- Posologia: 16U/Kg
- Regra prática: Peso x 0,16 = ml/h
- Dosar PTTa de 6/6h - Alvo -> 1,5-2,5x o controle



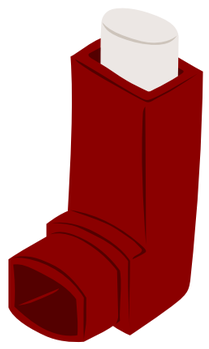
EDEMA AGUDO DE PULMÃO

1. Furosemida (20mg/2ml) ---------- IV
Fazer X ampolas IV (pelo menos dose 2x a dose de uso domiciliar do paciente)

2. Nitroglicerina (Tridil) (50mg/5ml) ---------- IV
Diluir 1 ampola em 245ml SG 5% e infundir em BIC a X ml/h

3. Morfina (10mg/ml) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 9ml ABD e fazer 3-5ml EV

4. Dobutamina (250mg/20ml) ---------- IV
Diluir 1 ampola (20ml) em 230 ml SF 0,9%



ASMA

Uso inalatório

1.Salbutamol (100mcg/jato) ---------- 1 frasco
2.Ipratrópio (Atrovent®) ---------- 1 frasco
Dose de ataque: Inalar 8 jatos de até 20/20min na 1ª hr
Após estabilização: manter doses fixas 1/1h; 4/4h, conforme sintomas

Uso intravenoso (corticóide)

3. Hidrocortisona 100mg ---------- IV
Fazer 100mg 24/24h

Opção:
4.Prednisona 20mg/cp ---------- 2cp VO

Nebulização

1. Fenoterol

a. Crianças: (peso/3) gotas + 5 ml de SF 0,9% em nebulização com O2 a 4 L/minuto
b. Adultos: 10-20 gotas + 5 ml de SF 0,9% em nebulização com O2 a 4 L/minuto

2. Ipratrópio (0,25mg/mL) ---------- 30 gotas em 5mL SF 0,9%

DPOC

Tratamento das crises

1.Salbutamol (100mcg/jato) ---------- 1 frasco
2.Ipratrópio (Atrovent®) ---------- 1 frasco

Dose de ataque: Inalar 8 jatos de até 20/20min na 1ª hr
Após estabilização: manter doses fixas 1/1h; 4/4h, conforme sintomas Uso intravenoso (corticóide)

3. Hidrocortisona 100mg ---------- IV
Fazer 100mg 24/24h

Opção:

4.Prednisona 20mg/cp ---------- 2cp VO

Nebulização

1. Fenoterol
Diluir 10-20 gotas + 5 ml de SF 0,9% em nebulização com O2 a 4 L/minuto

2. Ipratrópio (0,25mg/mL) ---------- 30 gotas em 5ml SF 0,9%

DPOC

Tratamento de manutenção

1.Seretide (Salmeterol/Fluticasona) 25 / 50mcg / jato - uso contínuo
Inalar 2 jatos de 12/12h

2.Spiriva (Tiotrópio) 2,5mcg/jato ---------- uso contínuo
Inalar 2 jatos pela manhã

HEMORRAGIA DIGESTIVA

1. Omeprazol (40mg/10ml) ---------- 1 ampola
Fazer 1 ampola (40mg) de 12/12h

2. Terlipressina (1mg/1ml) ---------- 2 ampolas
Fazer 2mg (2 amp) EV em bolus + 1 mg a cada 4hrs

3. Octreotide (0,5mg/ml) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 250ml de SF 0,9% e correr a 25ml/h

4. Profilaxia de PBE:

- Ceftriaxona 1g 24/24h (1ª opção)
- Norfloxacino 400mg VO 12/12hrs por 7 dias

CETOACIDOSE

Insulinoterapia

Apenas prescrever insulina se o K inicial > 3,3 mEq/L

Dose de ataque (bolus):

- Insulina regular: 0,1-0,15 U/Kg IV

Dose de manutenção:

- BIC: 0,1 U/Kg/h
- Como preparar: Insulina regular 50 U + SF 0,9% 250mL (1ml = 0,2 U)

Monitorização:

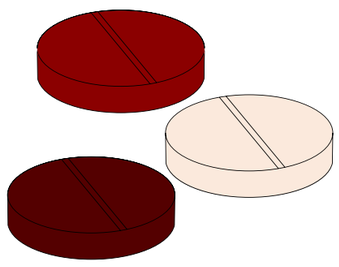
- Glicemia capilar 1/1h
- Taxa ideal de queda da glicemia: 50-70mg/dL/h

Suspender a BIC com insuluina:

- Controle do fator precipitante E
- Glicemia < 250mg/dL E
- pH > 7,3 e HCO3 > 18 mEq/L

Antes de suspender a insulina IV

- Prescrever 10 U de insulina regular SC
- Esperar cerca de uma hora antes de desligar a bomba



ANTIMICROBIANOS

1. Meropenem (frascos de 500mg e 1g) ---------- IV
1g de 8/8h (2g de 8/8h em infecções mais graves)

2. Vancomicina ---------- IV
1g de 12/12h EV – A partir da 4ª dose -> monitorizar nível sérico e ajustar próximas doses (Nível ideal: 10-20) – Infundir em pelo menos 1h

3. Piperacilina-Tazobactam ---------- IV
4,5g de 8/8h ou 6/6h EV (Diluir em 100ml de SF 0,9% e infundir em 30-60min)

4. Polimixina B (500.000/amp) ---------- IV
15-25.000 U/Kg/Dia dividas de 12/12h (dose max: 2.000.000)

5. Cefepime ---------- IV
1-2g a cada 12h
Neutropenia febril: 2g a cada 8h

6. Ceftriaxona (1g/ampola) ---------- IV
Diluir 1 ampola em 250ml de SF0,9% e fazer em 20min de 12/12h

7. Ciprofloxacino (400mg/200ml) ---------- IV
Fazer 1 frasco de 12/12hrs

8. Levofloxacino (500mg/100ml) ---------- IV
Fazer 1 frasco/bolsa e meio (750mg) 1x ao dia (Pneumonia)

9. Amoxicilina+clavulanato (500mg+100mg/ampola) ---------- IV
Diluir 1 ampola em 50mL de SF 0,9% e infundir em 30min

ANALGÉSICOS

1.Dipirona (1.000mg/2mL) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 8 ml SF 0.9% e fazer IV

2.Buscopan® Composto ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 15ml de ABD e fazer IV lentamente (5min)

3.Paracetamol + codeína (500 + 30) (Tylex®) ----- Tomar 1cp de 6/6hrs

4.Tramadol (100mg/2ml) ---------- 1 frasco/ampola
Diluir 1 ampola em 100 ml SF 0,9% e fazer IV em 30 min

5.Morfina (10mg/ml) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 10 ml de ABD e fazer 3-5 ml/dose

Equivalência da morfina EV para morfina oral: 1:3 (10mg EV = 30mg Oral)

Morfina em BIC – Fazer uma solução 1:1 – 10 ampolas (10mg/ml) em 90ml de SF 0,9% e iniciar a 2- 3ml/h.

ANALGÉSICOS

AINES Injetáveis

1. Cetoprofeno (Profenid) (100mg/2ml) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 100ml de SF0,9% e correr em 20 min

2. Diclofenaco Sódico (Voltaren) (75mg/3ml) ---------- 1 ampola
Fazer 1 ampola IM

4. Tenoxicam (Tilatil®) (20mg/ampola) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 2 ml de ABD e aplicar IM ou EV em bolus

AINES via oral

1. Nimesulida 100mg ---------- Tomar 1cp de 12/12hrs

2. Diclofenaco Sódico (Voltaren) 50mg ---------- Tomar 1cp de 8/8hrs

3. Diclofenado Potássico (Cataflam) 50mg --------- Tomar 1cp de 8/8hrs

4. Celecoxib (Celebra) 200mg ---------- Tomar 1cp de 12/12hrs

5. Tenoxicam (Tilatil) 20mg ---------- Tomar 1cp 1x ao dia

6. Ibuprofeno 600 mg ---------- Tomar 1cp de 8/8hrs

VITAMINAS

Tiamina
(Wernicke-Korsakoff)

1. Tiamina (100mg - ampola) ---------- EV
5 ampolas (500mg) de 8/8h por 2dias.
Em seguida 2,5 ampolas (250mg) de 24/24h por 5 dias.
Posteriormente, dose de manutenção de 100mg 24/24h.

Vitamina B12
(Anemia perniciosa)

1-Cianocobalamina 1000mcg (Citoneurim) ---------- IM
Aplicar via IM 1 ampola por semana durante 4 semanas;
Após, aplicar 1 ampola por mês.

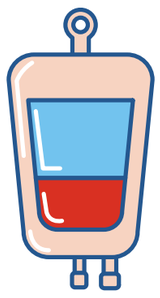
VITAMINAS

Ferro (Anemia ferropriva)

1.Noripurum (100mg/5ml) ---------- x ampolas
Diluir 5-10ml de noripurum em 250ml de SF 0,9%
Aplicar 1-3x por semana, conforme objetivo final de nível de Hb

Via oral

1.Sulfato ferroso (60mg Fe elementar) ---------- uso cont
Tomar 1 cp 1h antes do café, almoço e jantar, juntamente com 1 copo de suco de laranja



HEMOCOMPONENTES

Concentrado de hemácias

- 1 Bolsa = 1 Unidade = 300ml
- Velocidade de infusão: 60-120min (ideal); Máx de 4h
- Acesso venoso exclusivo;
- Não adicionar medicamentos concomitantemente
- Elevação de Hb esperada - 1-1,5 pontos

Irradiado:

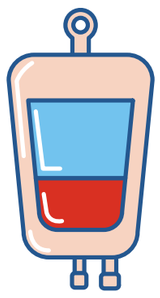
- *Prevenção do doença hospedeiro-enxerto pós-transfusional*
- *Indicações:*
  - *Pós transplante de medula e de órgãos sólidos imunossuprimidos*
  - *Receptor parente de 7 grau do doador*
  - *Linforno de Hodkin*

Lavado

- *Indicação:*
  - *Reação alérgica recorrente, associado a transfusão e não evitadas com uso de medicamentos*

Desleucocitado

- *Indicações:*
  - *Prevenção da reação febril hemolitica aguda*
  - *Prevenção de aloimunização HLA*
  - *Politransfundidos*
  - *Reação hemolitica mediado por HLA*
  - *Paciente renal crónico candidato ao transplante*
  - *Prevenção da transmissão de CMV*



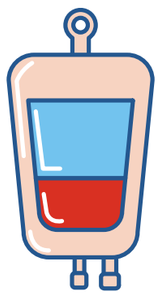
HEMOCOMPONENTES

Concentrado de plaquetas

Dose adulto: 1 pool – 1 unidade para cada 7-10Kg

Indicações:

- Plaquetas < 10.000
- Plaquetas < 20.000: Paciente febril, Mucosite grave, uso de anticoagulante, risco de contagem < 10.000 nos próximos exames
- Plaquetas <50.000: Sangramento importante do TGI ou genitourinário
- Sangramento espontâneo no SNA ou oftálmico com plaq < 100.000
- EDA, broncoscopia com biopsia: nível de plaq desejado: >50.000
- Cateter central, punção lombar, paracentese, toracocentese, extração dentária: > 50.000
- Cirurgias neurológicas e oftalmológicas: >100.000



HEMOCOMPONENTES

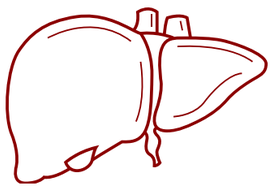
Crioprecipitado

- Indicação: hipofibrinogenemia
- Cada unidade: 10-20ml
- Dose: 1 unidade para cada 10Kg

Plasma fresco congelado

Indicações:

Deficiência múltipla de fatores de coagulação e sangramento ativo
Prevenção de sangramento em pacientes com def. de fatores de coagulação que serão submetidos a procedimentos invasivos ou com RNI > 1,5 ou TTPa > 1,5x o controle



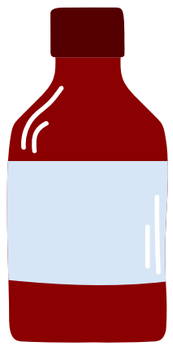
ENCEFALOPATIA HEPÁTICA

Via oral

1.Lactulose 667mg/ml ---------- Frasco
20ml 8/8h; 6/6h até 3 evacuações diárias

Via retal

2.Lactulose 667mg/ml ---------- Frasco
Misturar 130ml de Lactulose em 370ml de Glicerina e fazer via retal



ALBUMINA

Albumina 20% (50ml/frasco) - cada frasco = 10g

Profilaxia de síndrome hepatorrenal (SHR) na PBE

- No D1 fazer 1,5g/Kg de peso, EV, em 6h
- No D3 fazer 1g/Kg de peso, EV, em 6h

Prevenção de SHR após paracentese > 5 L

- Repor 8-10g de albumina para cada litro retirado no total

Confirmação e tratamento da SHR

- Nos primeiros 2 dias da disfunção renal, fazer 1g/kg de peso/dia de albumina para dar o diagnóstico (positivo caso não ocorra melhora da injúria renal)
- **Tratamento:**
  - 20-40g de albumina por dia + Terlipressina por 5 dias

CÓLICA NEFRÉTICA

Uso Intravenoso

1. Cetoprofeno (Profenid) (100mg/2ml) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 100ml de SF 0,9% e correr em 20 min

2. Dipirona 1g ---------- 1 ampola
Fazer 1 ampola IV

3.Morfina (10mg/ml) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 10ml de ABD e fazer 4-5ml

4.Ondansetrona (Vonau) ---------- 1 ampola
Fazer 1 ampola IV

Uso Oral

1.Dipirona 1g ---------- 1 caixa
Tomar 1g de 6/6h

2.Diclofenaco 50mg ---------- 1 caixa
Tomar 1cp de 12/12h

3.Tansulosina 0,4mg ---------- 1 caixa
Tomar 1cp à noite por 10 dias

ENXAQUECA

Injetável

1.Sumax 6mg/0,5ml ---------- 1 ampola
Aplicar 6mg no subcutâneo, podendo ser aplicada nova injeção subcutânea de 6 mg de sumatriptana após uma hora, no mínimo, da aplicação da primeira dose. A dose máxima em 24 horas é somente de duas injeções de 6 mg (12 mg de sumatriptana ao dia).

Opções:

2.Cetoprofeno (Profenid) (100mg/2ml) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 100mL de SF 0,9% e correr em 20 min

3.Dexametasona (10mg/2,5ml) ---------- 1 ampola
Fazer 1 ampola IM

ENXAQUECA

Uso oral

1.Sumaxpro (Sumatriptano + Naproxeno) 50/500mg VO
Tomar 1cp no início da crise. Se ausência de melhora, repetir dose após 2h

Opções:

2.Naproxeno 500mg ---------- 1 ampola
Tomar 1cp de até 12/12h

3.Ibuprofeno 600mg ---------- 1 ampola
Tomar 1cp de até 8/8h

CRISE CONVULSIVA

Uso intravenoso

1.Diazepam (10mg/2ml) ---------- 1 ampola
Fazer 1 ampola IV lentamente

2.Fenitoína (Hidantal) 50mg/ml ---------- 5ml/ampola
Dose de hidantoinização: 15-20mg/Kg
Diluir 4-5 ampolas em 250ml de solução de cloreto de sódio 0,9% e correr em 30-60min. Não exceder 50mg/min.

OBG: as diluições com soro glicosado normalmente precipitam o produto e não estão indicadas

HIPERTENSÃO INTRACRANIANA

Uso injetável

1.NaCl 20% ---------- 0,7ml/Kg

Aprox 30ml EV lento

2.Manitol 20% (200mg/ml) ---------- 0,25 - 1,0g/Kg

Fazer X ml IV até de 6/6h

19
K
Potassium
39.098

DISTÚRBIOS DO K

Hipercalemia

Se repercussão eletrocardiográfica:

1.Gluconato de cálcio (10ml/ampola) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola em 50ml de SF 0,9% e fazer EV em 3min.

Lembrete: O Gluconato de cálcio não reduz os níveis de K; ele atua na estabilização elétrica do coração impedindo surgimento de arritmias.

Medidas que alteram a calemia

2.Feoterol ---------- micronebulização
Diluir 10-15 gotas em 5ml de SF 0,9% e fazer nebulização de 4/4h

3.Solução polarizante ---------- IV
Insulina regular 10UI em 100ml de SG 50%; ou 10UI diluídas em 500ml de SG 10%.

4.Poliestieronosulfonato de cálcio (Sorcal) ---------- VO
Diluir 30g em 100ml de manitol 10% ou água e fazer VO de até 4/4hrs

5.Furosemida ---------- IV
Fazer 1 ampola IV

19
K
Potassium
39.098

DISTÚRBIOS DO K

Hipocalemia

<u>K > 3,0 - Reposição VO</u>

1.KCl xarope 6% ---------- Tomar VO 10-30ml de 6/6hrs

2.KCl (6 mEq/cp) ---------- Tomar 1cp após as refeições 6/6hrs

<u>K < 3,0 - Reposição Venosa</u>

1.KCl 10% (Amp. 10ml) ---------- IV

Diluir 2 ampolas em 500ml de SF 0,9% e correr em 2-3h (Acesso periférico)

Em caso de hipocalemia muito importante e paciente com acesso venoso central, concentrações maiores podem ser aceitáveis (Ex: 4 ampolas em 500ml SF 0,9%)

Na DISTÚRBIOS DO NA

Hiponatremia

Uso injetável

Salina 3%

1.NaCl 3% (513 mEq/L) ---------- IV em BIC

Preparo da solução:

- Diluir 30 ampolas de NaCl 10% em 700ml de ABD ou
- 75 ml de NaCl 20% em 425ml de ABD - solução de 500ml com 255meq - ou 510meq/L

Calcular a variação de Na com 1L de solução:
[513 - Na do paciente] dividido por [Água corporal + 1]

Após determinar a quantidade em ml que deverá ser infundida em 24h para corrigir no ***máx 10 mEq em 24hrs,*** *estabelecer a taxa de infusão em BIC*

Na DISTÚRBIOS DO NA

Hipernatremia

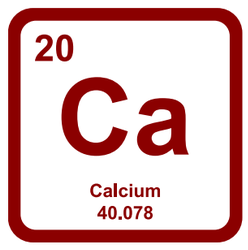
1.Água filtrada por SNE ---------- 200ml de 6/6h

Opções intravenosa

1.NaCl 0,45% (77mEq/L) ---------- IV
Preparo da solução: Diluir 22ml de NaCl a 20% (77mEq) em 1L de SGI 5%

ou

2.SGI 5% ---------- IV
Infundir a 60ml/h

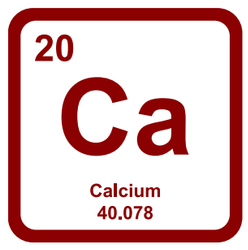


DISTÚRBIOS DO CA

Hipercalcemia

1.Iniciar hidratação EV a 200-300ml/h - para manter diurese em torno de 100-150ml/h

2.Pamidronato 60-90mg IV em 4h



DISTÚRBIOS DO CA

Hipocalcemia

1.Gluconato de cálcio 10% (Amp. 10ml) ---------- IV

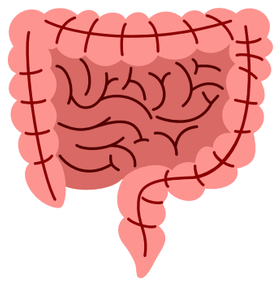
Diluir 1 ampola em 50ml de SF 0,9% ou SGI 5% e fazer em 1h; ou 5 ampolas (50ml) em 500ml de SF 0,9% e correr a 50ml/h

DISTÚRBIOS DO MG

Hipomagnesemia

1.Sulfato de Magnésio 50% (10ml/ampola) ---------- IV

Diluir 4-5ml em 500ml de SF 0,9% e correr em 4-5h



CONSTIPAÇÃO

Uso oral

1.Polietilenoglicol PM 4000 ---------- 60g cada sachê
Diluir um sachê em 50ml de água e tomar 1x ao dia sempre no mesmo horário

- Dose de desimpactação: 2mg/Kg
- Dose de manutenção: 1mg/kg

2.Lactulose (xarope 667mg/mL) ---------- 1 frasco
Tomar VO 15ml de 8/8hrs

Clister

1. **Clister glicerinado 12 ---** 500ml solução retal (10ml/kg)

DIARREIA

Uso oral

1. Floratil® (200mg/cp) ---------- 1 caixa
Tomar 1cp de 12/12h

2. Racecadotril (100mg/cp) (Tiorfan®) ---------- 1 caixa
Tomar 1cp de 8/8h (Dose máx de 400mg)

3. Sais para hidratação oral (Rehidrat®) ----- X envelopes
Diluir 1 envolope em 500ml de água e beber durante todo o dia

Se indicação de antibiótico:

1.Ciprofloxacino 500mg ---------- 10cp
Tomar 1cp 12/12h por 5 dias

OTITES

Otite média

Uso oral

1.Amoxicilina+Clavulanato (500+125mg) ---------- 30cp
Tomar 1cp de 8/8h por 10-14 dias

Otite externa

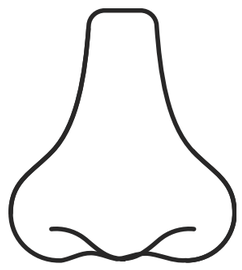
Uso tópico

1.Otociriax (ciprofloxacino+hidrocortisona) ---------- 1 frasco
Aplicar 3 gotas de 12/12h no ouvido acometido

Opções com anestésico

2.Otosynalar ---------- 1 frasco
Aplicar 3 gotas de 12/12h no ouvido acometido

3. Elotin ---------- 1 frasco
Aplicar 3 gotas de 12/12h no ouvido acometido



SINUSITE

Uso oral

1.Amoxicilina+clavulanato (500+125mg) ---------- 30 cp
Tomar 1cp de 8/8h por 10-14 dias

Opções:
2.Levofloxacino 750mg ---------- 7 cp
Tomar 1cp por dia por 7 dias

3.Moxifloxacino 400mg ---------- 7cp
Tomar 1cp por dia por 7 dias

4.Clindamicina 300mg ---------- 28cp
Tomar 1cp de 6/6h por 7 dias

Sintomáticos

Intranasal

1.Soro fisiológico 0,9% (Nasojet) ---------- 1 frasco
Aplicar 2 jatos em cada narina de 6/6h
Corticoterapia

Uso oral

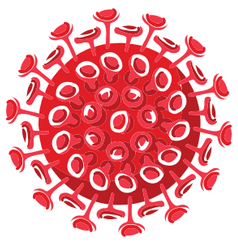
1.Prednisona 20mg ---------- 5cp
Tomar 1cp por dia por 5 dias

SINUSITE

Uso ocular

1.Tobramicina + dexametasona (Tobradex) ------- colírio
Pingar 1 gota no olho acometido de 6/6h por 7 dias

2.Soro fisiológico 0,9% ---------- 1 frasco
Lavar abundantemente sempre que houver acúmulo de secreções



HERPES ZOSTER E SIMPLEX

Herpes Zoster

Uso oral

1.Aciclovir 400mg ---------- 70cp

Tomar 2cp (800mg) 5x ao dia por 7 dias

Herpes Simplex

Uso oral

2.Aciclovir 200mg ---------- 35 cp

Lavar abundantemente sempre que houver acúmulo de secreções

SÍFILIS

Sífilis precoce (primária e secundária)

Uso intramuscular

1.Penicilina Benzatina 1.200.000 U ---------- 2 ampolas
Aplicar via IM 1 ampola em cada nádega (dose única)

Sífilis tardia

Uso intramuscular

1.Penicilina Benzatina 1.200.000 U ---------- 2 ampolas
Aplicar via IM 1 ampola em cada nádega (2 ampolas dia)
Uma vez por semana, durante 3 semanas

CORRIMENTO VAGINAL

Candidíase

Uso intravaginal

1.Clotrimazol 2% (creme) ---------- 2 ampolas
Aplicar via intravaginal o conteúdo de um aplicador cheio diariamente antes de dormir por 3 dias

Opções

2.Clotrimazol 1% (creme) ---------- 7 aplicações
Aplicar via IM 1 ampola em cada nádega (2 ampolas dia) Uma vez por semana, durante 3 semanas

3.Miconazol 2% (creme) ---------- 7 aplicações
Aplicar via intravaginal o conteúdo de um aplicador cheio diariamente antes de dormir por 7 dias.

Opção oral para casos leves

4.Fluconazol 150mg ---------- dose única
Tomar 1cp dose única

CORRIMENTO VAGINAL

Vaginose

Uso oral

1.Metronidazol 500mg ---------- 14 cp

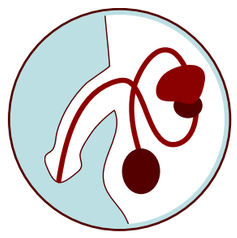
Tomar 1cp de 12/12h por 7 dias

Tricomoníase

Uso oral

1.Metronidazol 500mg ---------- 14cp

Tomar 1cp de 12/12h por 7 dias



URETRITES

Gonocóccica

1.Ceftriaxona 250mg ---------- 1 dose IM

+

2.Azitromicina 500mg ---------- 2cp

Tomar 2cp em dose única

Não gonocóccica

1.Azitromicina 500mg ---------- 2cp

Tomar 2cp em dose única

Opção:

2.Doxiciclina 100mg ---------- 14cp

Tomar 1cp de 12/12h por 7 dias

LOMBALGIA

Uso Injetável

1.Dexa-Citoneurin ---------- 3 ampolas

Aplicar 1 amp via IM a cada 3 dias

2. Cetoprofeno (Profenid) (100mg/2ml) ---------- 1 ampola

Diluir 1 ampola em 100ml de SF 0,9% e correr em 20 min

Uso oral

1. Sedilax (Cafeína, Carisoprodol, Diclofenado Sódico, Paracetamol)

Tomar 1cp 8/8hrs

ANAFILAXIA E ALERGIAS

Adrenalina IM – 1ª opção no choque anafilático

1. Adrenalina ---------- (1:1000 – ampola padrão 1mL)
Fazer 0,3ml IM (adultos)

2. Adrenalina ---------- (1:1000 – ampola padrão 1mL)
Fazer 0,01ml/Kg/dose IM - Máx: 0,3ml - (Crianças)

Adrenalina IV – Casos graves; PCR

1.Adrenalina (1:1000 / mL) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola padrão em 9ml de SF 0,9% e fazer 0,1 a 0,3ml em 5min (adultos)

2.Adrenalina (1:1000 / mL) ---------- 1 ampola
Diluir 1 ampola padrão em 9ml de SF 0,9% e fazer 0,01 ml/Kg/dose - Máx de 0,3ml (crianças)

ANAFILAXIA E ALERGIAS

Quadros leves

1.Difenidramina (50mg/ml) ---------- 1 ampola

Fazer 1 ampola IV até de 4/4h

2.Ranitidina (50mg/2 ml) ---------- 1 ampola

Diluir 1 ampola em 20ml de ABD ou SF 0,9% e infundir em 5min

3.Hidrocortisona 100mg ---------- 1 ampola

Fazer 1 ampola IV 24/24h

CONTROLE GLICÊMICO NA UTI

- **Iniciar sempre que 2 glicemias > 180mg/dL**
- **Objetivo de manter glicemias entre 140 e 180mg/dL**

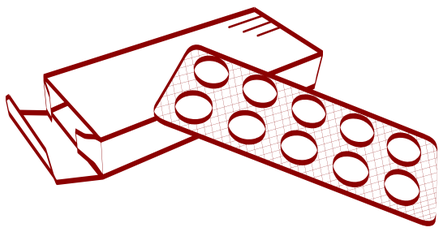
Diluição: 100UI de insulina regular em 100ml de SF 0,9%

Início:

- Glicemias > 180: 2ml/h
- Glicemias > 220: 4ml/h

Evolução:

- Glicemias < 60: desligar a bomba; administrar 40ml de SG 50%
- Glicemias < 100: desligar a bomba
- Glicemias > 160-180: Manter velocidade de infusão 1ml/h
- Glicemias > 189: aumentar 2ml/h



PARACETAMOL - INTOXICAÇÃO

Uso oral

1.N-acetilcisteína ---------- 18 doses

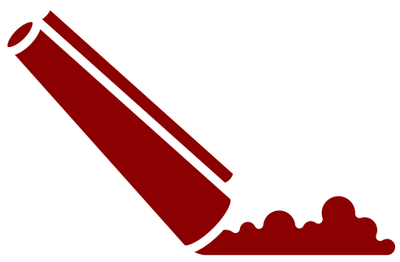
Dose de ataque (140mg/Kg) diluído em 200ml de SGI 5% ou suco de laranja + 17 doses de manutenção (70mg/Kg) de 4/4hrs

"CHUMBINHO" - INTOXICAÇÃO

Antídoto contra anticolinesterásicos
Tratamento dos sintomas muscarínicos

1.Atropina (0,5mg/ml) ---------- IV

Fazer 1-2 ampolas em bolus, conforme sintomas muscarínicos. Não há dose máxima estabelecida. Fazer até controle dos sintomas.



COCAÍNA - INTOXICAÇÃO

Controle dos sintomas adrenérgicos

Uso intravenoso

1.Midazolam (5mg/ml) ---------- 1 ampola

Diluir 1 ampola em 9ml de ABD e fazer 5ml

Droga de meia vida mais curta

Opção

2.Diazepam 10mg/ampola ---------- 1 ampola

Fazer conforme intensidade dos sintomas adrenérgicos

VERTIGEM

Crise aguda vertiginosa

Uso oral

1.Dimenidrato 50mg ---------- 1 caixa

Tomar 1cp de até 6/6h

ou

2.Meclizina 25mg ---------- 1 caixa

Tomar 1cp de até 6/6h

Opção intravenosa

3.Dimenidrato ---------- IV

Aplicar 1 ampola IV de até 6/6h

VERTIGEM

Tratamento de manutenção

Se suspeita de doença de Menière

Uso oral

1.Betaistina 24mg ---------- 1 caixa

Tomar 1cp de 12/12h

CONSULTA RÁPIDA

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR

Epinefrina - Ampolas de 1mg - Dose inicial: 1mg a cada 3 min

Amiodarona - Ampolas de 150mg - Dose inicial: 300mg

Bicarbonato de sódio 8,4% - 1 ml = 1 mEq - Dose inicial: 1 mEq/Kg

Sulfato de magnésio 50% - Ampola de 10ml = 5g - Dose inicial: 1-2g

BOM PLANTÃO!